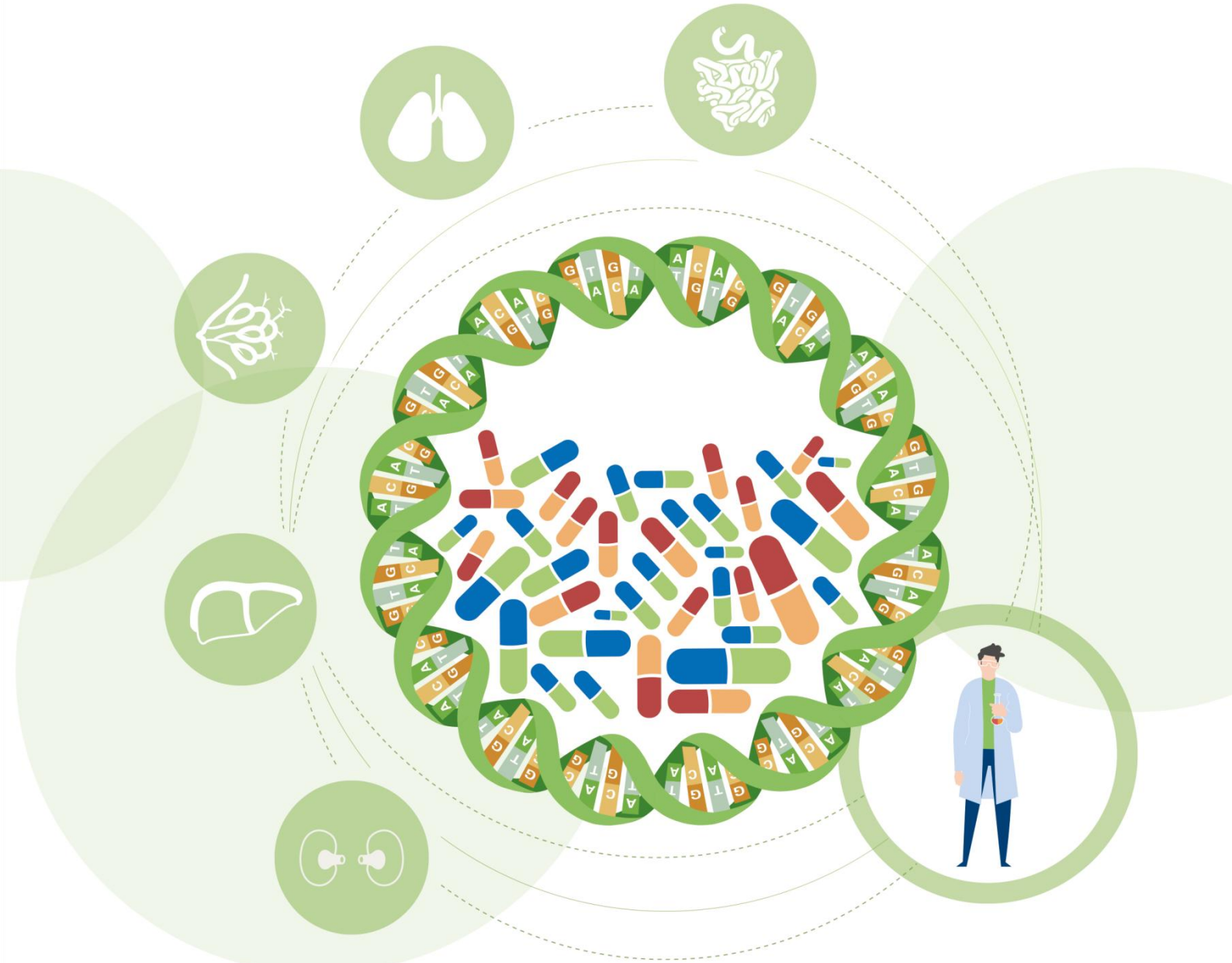
Novogene

CAP ACCREDITED
COLLEGE of AMERICAN PATHOLOGISTS



肿瘤个性化诊疗指导
PD-L1 检测报告

基因科技守护生命健康

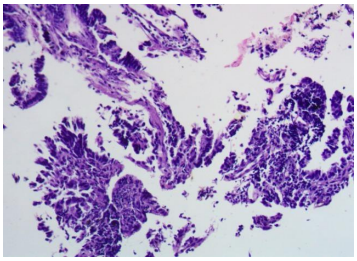
肿瘤个体化诊疗检测报告

患者姓名： 程光大	**性别：** 男	**年龄：** 75 岁	**送检样本：** 石蜡贴片
原样本编号： TKHS250030951-1A	**病人 ID：** MK0125019728	**采样日期：** NA	**送检单位：** -
原病理/临床诊断： 肺癌			**接收日期：** 2025-04-01

组织切片质控

肿瘤细胞数是否大于 100 个	是

镜下描述：肿瘤组织呈浸润性生长，局部可见腺样结构，伴小灶坏死及间质内促纤维结缔组织增生。瘤细胞较大，呈圆形椭圆形，胞浆嗜伊红，细胞核异型性较大，可见奇异核及瘤巨细胞，可见病理性核分裂。

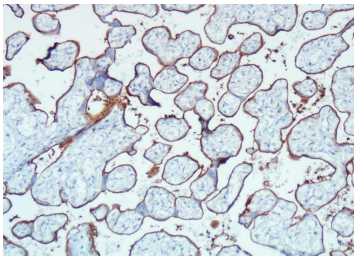


HE 染色切片 200X

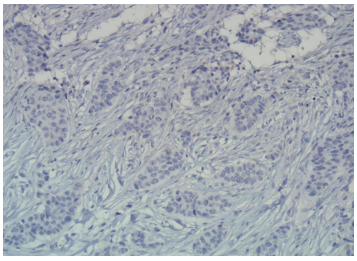
检测结果：

检测项目	检测方法	检测抗体	检测结果
PD-L1-22C3	IHC	DAKO 22C3	TPS：<1%
			CPS：20

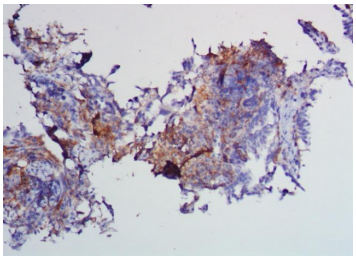
检测图谱：



PD-L122C3 阳性对照 200X



PD-L122C3 阴性对照 200X



PD-L122C3 200X

检测人： 许志红　　**审核医生：**　　**报告日期：** 2025 年 04 月 04 日

本次检测仅对所检测的标本负责，检测结果仅供医生参考，不能作为制定、修改、调整用药方案的唯一依据。

参考资料 Reference Data

一.结果解析参考

$$\text{TPS（Tumor Proportion Score）} = \frac{\text{PD-L1 染色细胞(肿瘤细胞)数量}}{\text{活的肿瘤细胞总数}} \times 100\%$$

$$\text{CPS（Combined Positive Score）} = \frac{\text{PD-L1 染色细胞(肿瘤细胞+淋巴细胞+巨噬细胞)数量}}{\text{活的肿瘤细胞总数}} \times 100$$

CPS 结果采用 0~100 数值来 表示，当计算结果超过 100 时，最终结果按照 100 来计算。

程序性死亡受体 1(PD-1)是一种重要的免疫抑制分子，主要在激活的 T 细胞和 B 细胞中表达。肿瘤细胞中高表达程序性死亡配体 1(PD-L1)，与 PD-1 结合后可抑制 T 细胞激活，从而使肿瘤细胞躲避免疫系统的识别与攻击。通过 PD-1/PD-L1 抑制剂阻断该信号通路，阻断负向调控信号，能够使 T 细胞恢复活性，增强免疫应答。近期研究发现 PD-1 和 PD-L1 抑制剂在非小细胞肺癌、黑色素瘤、膀胱癌等多种肿瘤类型中疗效显著,其中肿瘤组织中 PD-L1 的表达水平对预测 PD-1 和 PD-L1 抑制剂疗效具有重要意义。

二.结果声明

本报告仅对本次送检的样本负责，结果仅供临床参考。

未严格按照本实验室要求采集和送检样本，将可能导致不准确的检测结果。

如对本报告有异议，请于 7 个工作日内与我们联系。

三.PD-L1 表达阳性阈值

癌种	判读标准	临床意义
非小细胞肺癌(NSCLC)	PD-L1 22C3 TPS≥1%	NMPA/FDA批准帕博利珠单抗单药一线治疗PD-L1 TPS≥1% 无EGFR和ALK基因突变的局部晚期或转移性NSCLC患者。FDA批准帕博利珠单抗单药治疗 PD-L1 TPS≥1% 无EGFR和ALK基因突变的，在含铂化疗期间或之后出现疾病进展的转移性NSCLC患者。
非小细胞肺癌(NSCLC)	PD-L1 22C3 TPS≥50%	FDA批准Cemiplimab-rwlc一线治疗PD-L1 TPS≥50% 转移性或不适合手术切除或根治性放化疗，无EGFR、ALK或ROS1突变的局部晚期NSCLC成人患者。
食管鳞状细胞癌(ESCC)	PD-L1 22C3 CPS≥10	FDA批准帕博利珠单抗单药用于先前接受过一种或多种系统治疗、PD-L1 CPS≥10 的局部晚期或转移性ESCC患者的治疗，这些患者不适合手术切除或根治性放化疗。NMPA批准帕博利珠单抗用于食管鳞状细胞癌PD-L1 CPS≥10的既往一线全身治疗失败的、局部晚期或转移性ESCC患者的治疗。
三阴乳腺癌(TNBC)	PD-L1 22C3 CPS≥10	FDA批准帕博利珠单抗联合化疗治疗PD-L1 CPS≥10，局部复发无法切除或转移性TNBC患者。
三阴乳腺癌(TNBC)	PD-L1 22C3 CPS≥20	NMPA批准帕博利珠单抗联合化疗新辅助治疗并在手术后继续帕博利珠单抗单药辅助治疗，用于PD-L1 CPS≥20的早期高危TNBC患者的治疗。
宫颈癌(CC)	PD-L1 22C3 CPS≥1	FDA批准帕博利珠单抗联合化疗（联用或不联用贝伐珠单抗）治疗PD-L1 CPS≥1 的疾病反复、复发或转移CC患者。FDA批准帕博利珠单抗用于治疗表达PD-L1 CPS≥1既往在化疗或化疗后疾病进展的复发或转移性CC患者。
胃癌/胃食管交界腺癌(GC/GEJ)	PD-L1 22C3 CPS≥1	FDA批准帕博利珠单抗联合曲妥珠单抗和化疗一线治疗 PD-L1 CPS≥1局部晚期不可切除或转移 HER2阳性的GC或GEJ成人患者。
头颈部鳞状细胞癌(HNSCC)	PD-L1 22C3 CPS≥1	FDA批准帕博利珠单抗单药一线治疗肿瘤细胞表达PD-L1 CPS≥1的转移性或不可切除复发性的HNSCC患者。
头颈部鳞状细胞癌(HNSCC)	PD-L1 22C3 CPS≥20	NMPA批准帕博利珠单抗单药用于PD-L1 CPS≥20 阳性的转移性或不可切除的复发性HNSCC的一线治疗。
非小细胞肺癌(NSCLC)	PD-L1 28-8 TPS≥1%	FDA批准纳武利尤单抗+CTLA-4抑制剂伊匹木单抗联合疗法，一线治疗PD-L1 TPS≥1%、EGFR 阴性及ALK 阴性转移性NSCLC成人患者。
头颈部鳞癌(SCCHN)	PD-L1 28-8 TPS≥1%	NMPA批准纳武利尤单抗适用于治疗接受含铂类方案治疗期间或之后出现疾病进展且肿瘤PD-L1 TPS≥1%的复发性或转移性SCCHN患者。
非小细胞肺癌(NSCLC)	PD-L1 E1L3N TPS≥1%	NMPA批准帕博利珠单抗单药一线治疗PD-L1 TPS≥1%无EGFR和ALK基因突变的局部晚期或转移性NSCLC患者。

注：NMPA：国家药品监督管理局；FDA：美国食品药品管理局。信息来源：FDA/NMPA 官网、药企官网发布信息。

广州诺禾医学检验实验室

广州市黄埔区开源大道 11 号 C6 栋 702 室

上海诺禾医学检验实验室

上海市闵行区绿洲环路 396 弄 9 号 201 室

天津诺禾医学检验实验室

天津市武清区创业总部基地 B07

T.020-32038634





诺禾医学　诺禾在线

www.novogene.com

中国 · 美国 · 英国 · 新加坡 · 荷兰 · 日本

China · USA · UK · Singapore · Netherlands · Japan

Novogene 诺禾致源